QCM de révision

60 questions · Corrigés regroupés à la fin

Système, professionnels et accès

Q01 Facile

Quelles propositions distinguent système de santé et système de soins ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le système de santé dépasse les seules interventions de soins.
- ☐ B. La prévention se déroule exclusivement lors d'une consultation.
- ☐ C. La surveillance participe au système de santé.
- ☐ D. Le financement est extérieur au système de santé.
- ☐ E. Les deux expressions désignent exactement le même périmètre.

Q02 Facile

Quels objectifs peuvent être associés au système de santé ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Préserver la santé de la population.
- ☐ B. Assurer des réponses adaptées aux besoins sans discrimination.
- ☐ C. Limiter l'action à la maladie déjà déclarée.
- ☐ D. Répondre aux attentes en matière de continuité.
- ☐ E. Garantir une offre strictement identique quels que soient les besoins.

Q03 Difficile

Deux communes proposent le même nombre de consultations, mais les habitants de l'une ne peuvent pas se déplacer. Quels constats sont justes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. L'absence de déplacement prouve un refus de soins.
- ☐ B. L'identité des nombres prouve l'équité obtenue.
- ☐ C. Les besoins et les conditions d'accès doivent être examinés.
- ☐ D. Le nombre proposé ne suffit pas à décrire l'accès effectif.
- ☐ E. La continuité des soins dépend uniquement du nombre de créneaux.

Q04 Facile

Quelles associations profession–ensemble sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Les infirmiers appartiennent à l'ensemble des auxiliaires médicaux.
- ☐ B. Le terme paramédical signifie absence de compétences propres.
- ☐ C. Le seul classement permet de connaître toute compétence de prescription.
- ☐ D. Les sages-femmes appartiennent aux professions médicales.
- ☐ E. Les chirurgiens-dentistes sont classés parmi les auxiliaires médicaux.

Q05 **Quels rôles correspondent aux ordres professionnels ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. Verser systématiquement le salaire de tous les professionnels.
- [ ] B. Veiller à la déontologie de la profession.
- [ ] C. Regrouper toutes les professions de santé dans un ordre unique.
- [ ] D. Suivre le tableau de la profession.
- [ ] E. Rembourser les soins des assurés.

Q06 **Une infirmière combine un emploi salarié et une activité libérale. Comment décrire cette situation ? (1 bonne réponse)**

Moyen

- [ ] A. Son salaire décrit le financement de toute la structure.
- [ ] B. Le statut peut être déterminé par la seule adresse du soin.
- [ ] C. L'exercice est mixte.
- [ ] D. Il est nécessairement exclusivement salarié.
- [ ] E. Le mot mixte désigne une absence de cadre professionnel.

Q07 **Concernant effectif et densité de professionnels : (2 bonnes réponses)**

Facile

- [ ] A. Une densité suffit à prouver la disponibilité d'un rendez-vous.
- [ ] B. La densité nécessite un dénominateur de population.
- [ ] C. Les deux mesures sont toujours numériquement égales.
- [ ] D. L'effectif est un nombre dans un périmètre défini.
- [ ] E. Comparer des unités différentes ne change pas l'interprétation.

Q08 **Un graphique présente un scénario d'effectif médical pour 2050. Comment le lire ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. La date peut être retirée sans perte d'information.
- [ ] B. L'effectif annoncé pour 2050 est déjà observé.
- [ ] C. Le résultat dépend d'hypothèses.
- [ ] D. Le scénario garantit un résultat individuel pour chaque patient.
- [ ] E. Il faut identifier la profession concernée.

Q09 Difficile

Un territoire possède plusieurs cabinets mais les délais sont longs et les déplacements difficiles. Quelles analyses sont pertinentes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Distinguer offre disponible et recours réalisable.
- ☐ B. Assimiler tout délai à une disparition des professionnels.
- ☐ C. Déduire un accès satisfaisant du seul nombre de cabinets.
- ☐ D. Ignorer la coordination dès que des professionnels sont présents.
- ☐ E. Étudier les obstacles concrets au rendez-vous.

Lieux, modalités et niveaux de recours

Q10 Facile

Quelles distinctions entre lieux de soins sont justes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Les soins de ville comprennent des interventions à domicile.
- ☐ B. Le médico-social associe soins, autonomie et projet de vie.
- ☐ C. Les trois ensembles sont trois degrés de gravité.
- ☐ D. Un EHPAD est automatiquement un hôpital.
- ☐ E. Une personne ne peut relever que d'un seul ensemble dans son parcours.

Q11 Moyen

Que permet d'affirmer le statut public ou privé d'un établissement ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le privé comprend des établissements non lucratifs et lucratifs.
- ☐ B. Le seul mot clinique permet de connaître toutes les autorisations.
- ☐ C. La spécialisation se déduit uniquement du caractère public.
- ☐ D. Tous les établissements privés ont exactement les mêmes missions.
- ☐ E. Les ESPIC appartiennent au secteur privé non lucratif présenté.

Q12 Moyen

Quelles associations activité–finalité sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. La réadaptation vise une récupération et une adaptation après une maladie ou une intervention.
- ☐ B. Une USLD désigne uniquement une consultation ponctuelle.
- ☐ C. MCO signifie médecine, chirurgie, obstétrique.
- ☐ D. SSR est le nom d'un mode de rémunération individuelle.
- ☐ E. La cancérologie est obligatoirement réservée à un seul statut juridique.

Q13 Facile

Quelles propositions distinguent lieu et modalité de prise en charge ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une consultation hospitalière peut avoir lieu sans hébergement.
- [ ] B. L'ambulatoire se déroule exclusivement en ville.
- [ ] C. Un hôpital de jour n'implique pas de nuitée.
- [ ] D. Le mot hospitalier suffit à déterminer le nombre de nuits.
- [ ] E. Tout examen hospitalier nécessite un séjour conventionnel.

Q14 Moyen

Un infirmier réalise un pansement au domicile. Quelles conclusions sont justifiées ? (1 bonne réponse)

- [ ] A. L'HAD exclut toute dimension hospitalière.
- [ ] B. Il faut connaître l'organisation de la prise en charge pour parler d'HAD.
- [ ] C. L'acte décrit prouve une HAD.
- [ ] D. Une organisation hospitalière ne peut jamais intervenir au domicile.
- [ ] E. Tout soin à domicile est nécessairement une hospitalisation conventionnelle.

Q15 Difficile

Avant une sortie en ambulatoire, quels éléments soutiennent la continuité ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Transmettre les informations utiles.
- [ ] B. Considérer que la sortie administrative termine tout besoin de coordination.
- [ ] C. Identifier les professionnels relais.
- [ ] D. Présumer que tous les domiciles offrent les mêmes conditions.
- [ ] E. Examiner les possibilités de suivi au domicile.

Q16 Facile

À propos des soins non programmés : (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le caractère imprévu ne suffit pas à conclure à une urgence vitale.
- [ ] B. Toute urgence vitale doit attendre un rendez-vous ordinaire.
- [ ] C. Programmé signifie dépourvu de tout besoin médical.
- [ ] D. Non programmé signifie obligatoirement réanimation.
- [ ] E. Le besoin ne peut pas attendre la programmation habituelle.

Q17 Moyen

Quel rôle correspond au service d'accès aux soins ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Attribuer automatiquement le même rendez-vous à toute demande.
- [ ] B. Être le nom d'un établissement d'hébergement.
- [ ] C. Participer à éviter des passages aux urgences pris en charge autrement.
- [ ] D. Mettre en relation la demande avec une réponse adaptée.
- [ ] E. Remplacer toute appréciation de la demande par un délai garanti.

Q18 Difficile

Une demande imprévue arrive alors que le médecin traitant est indisponible. Quels raisonnements sont appropriés ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Apprécier le besoin avant de choisir la réponse.
- ☐ B. Déduire une urgence vitale de la seule fermeture du cabinet.
- ☐ C. Reporter toute demande jusqu'au prochain suivi programmé.
- ☐ D. Ne pas assimiler automatiquement imprévu et urgence vitale.
- ☐ E. Garantir un délai fixe à partir d'un exemple général.

Q19 Facile

Quelles propositions décrivent le premier recours ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Il participe à la prévention et au suivi.
- ☐ B. Il est défini par une moindre valeur du soin.
- ☐ C. Il mobilise notamment généralistes, infirmiers et pharmaciens.
- ☐ D. Il désigne uniquement les actes expérimentaux.
- ☐ E. Il impose toujours une hospitalisation.

Q20 Moyen

Un cardiologue consulte en cabinet de ville. Quelles propositions sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Toute consultation en ville est obligatoirement primaire.
- ☐ B. Le niveau de recours est distinct du statut juridique.
- ☐ C. Toute activité en CHU est quaternaire.
- ☐ D. Un cabinet ne peut jamais proposer une expertise spécialisée.
- ☐ E. Une expertise spécialisée peut relever du deuxième recours en ville.

Q21 Moyen

Concernant les recours tertiaire et quaternaire : (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Un recours spécialisé rend toute coordination ultérieure inutile.
- ☐ B. Le quaternaire n'est pas une étape obligatoire de tout parcours.
- ☐ C. Tout patient doit atteindre le quaternaire pour terminer son suivi.
- ☐ D. Le niveau de recours est un classement de prestige des bâtiments.
- ☐ E. Le tertiaire mobilise des moyens spécialisés pour des prises en charge complexes.

Parcours et coordination

Q22 — Facile

Quelles fonctions sont associées au médecin traitant ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Se limiter à signer une lettre sans assurer de suivi.
- [ ] B. Participer à la prévention personnalisée.
- [ ] C. Être obligatoirement un médecin généraliste en cabinet libéral.
- [ ] D. Remplacer tous les autres professionnels.
- [ ] E. Articuler les interventions au cours du suivi.

Q23 — Moyen

Après un avis spécialisé, quelles actions soutiennent un parcours coordonné ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Déduire un remboursement exact de la seule présence d'un compte rendu.
- [ ] B. Relier les décisions spécialisées aux autres interventions.
- [ ] C. Transmettre les informations utiles à la poursuite du suivi.
- [ ] D. Considérer l'orientation initiale comme une coordination suffisante à elle seule.
- [ ] E. Écarter le médecin traitant dès qu'un spécialiste intervient.

Q24 — Difficile

Quelle lecture distingue organisation du parcours et remboursement ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le principe de coordination et le calcul financier doivent être distingués.
- [ ] B. Une exception d'accès direct supprime tout besoin d'information entre professionnels.
- [ ] C. La coordination n'a aucun lien avec la prise en charge financière.
- [ ] D. Une seule proportion décrit tous les parcours possibles.
- [ ] E. Une situation particulière demande de vérifier les règles applicables.

Q25 — Facile

Quelles dimensions élargissent le parcours de soins au parcours de santé ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Les besoins d'aide à la vie quotidienne.
- [ ] B. Le parcours de santé exclut les soins.
- [ ] C. L'accès aux droits et les ressources.
- [ ] D. Uniquement le nombre d'examens prescrits.
- [ ] E. Exclusivement les actes réalisés à l'hôpital.

Q26 Difficile

Une personne âgée rentre chez elle avec un pansement et une difficulté à préparer ses repas. Quelles démarches relèvent d'une approche globale ? (3 bonnes réponses)

- ☐ A. Considérer que le pansement résout tous les besoins de retour.
- ☐ B. Explorer les possibilités de repas et d'aide.
- ☐ C. Prévoir le relais pour le pansement.
- ☐ D. Séparer les intervenants en supprimant tout échange utile.
- ☐ E. Associer la personne à l'organisation.

Q27 Moyen

En période de chaleur, plusieurs personnes fragiles rencontrent des difficultés au domicile. Que montre une réponse coordonnée ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Des besoins sanitaires et sociaux peuvent être reliés.
- ☐ B. La surveillance suffit même sans organisation d'une réponse.
- ☐ C. Les ressources locales peuvent participer à la réponse.
- ☐ D. Un protocole identique convient nécessairement à tous.
- ☐ E. Seul l'hôpital peut intervenir dans cette coordination.

Q28 Moyen

Quelles propositions décrivent l'exercice coordonné en ville ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Seule une structure hospitalière peut coordonner.
- ☐ B. La coordination consiste à supprimer les rôles propres.
- ☐ C. Partager une adresse garantit tous les échanges nécessaires.
- ☐ D. Les professionnels d'une ESP peuvent rester dans des cabinets distincts.
- ☐ E. Un projet partagé contribue à la coordination.

Q29 Facile

Comment distinguer une MSP d'une CPTS ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Les deux sigles désignent obligatoirement le même bâtiment.
- ☐ B. La CPTS est une caisse de remboursement locale.
- ☐ C. La CPTS agit à une échelle territoriale.
- ☐ D. La MSP repose sur un projet pluriprofessionnel.
- ☐ E. Le centre de santé est présenté comme une structure sans professionnels.

Q30 **Quelles actions peuvent relever des missions d'une CPTS ? (3 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. Faciliter l'accès à un médecin traitant.
- [ ] B. Renforcer les liens ville-hôpital-médico-social.
- [ ] C. Se substituer à tous les professionnels pour chaque acte clinique.
- [ ] D. Organiser des actions de prévention adaptées au territoire.
- [ ] E. Voter la loi de financement de la Sécurité sociale.

Q31 **À quoi peuvent contribuer le DMP et Mon espace santé ? (2 bonnes réponses)**

Facile

- [ ] A. Remplacer toute appréciation professionnelle de la situation.
- [ ] B. Limiter les ruptures d'information entre intervenants.
- [ ] C. Transformer automatiquement chaque dossier en prescription.
- [ ] D. Aider à retrouver des informations nécessaires au parcours.
- [ ] E. Garantir que tout document doit être transmis à tous.

Q32 **Avant d'envoyer un compte rendu par messagerie sécurisée, que faut-il examiner ? (3 bonnes réponses)**

Difficile

- [ ] A. L'idée que tout destinataire équipé peut recevoir tous les dossiers.
- [ ] B. L'utilité des informations transmises.
- [ ] C. Le cadre de confidentialité.
- [ ] D. Le rôle du destinataire dans la prise en charge.
- [ ] E. Uniquement la possibilité technique d'ajouter une pièce jointe.

Q33 **Un document est accessible dans un outil de suivi. Quelles conclusions sont justes ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. Toute copie multiple améliore nécessairement le soin.
- [ ] B. L'accès technique efface toute exigence de confidentialité.
- [ ] C. L'utilité pour le suivi doit rester examinée.
- [ ] D. L'échange avec la personne reste important.
- [ ] E. La présence d'un dossier garantit une coordination effective.

Pilotage, histoire et institutions

Q34 — Facile

Quelles associations acteur–fonction sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Les acteurs du territoire n'ont aucun rôle dans la réponse aux besoins.
- ☐ B. L'ARS intervient à l'échelon régional.
- ☐ C. Le Parlement vote notamment la LFSS.
- ☐ D. Le ministère est une caisse locale de remboursement.
- ☐ E. L'ARS vote seule les lois nationales.

Q35 — Moyen

Quelles idées permettent de distinguer déconcentration et décentralisation ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Déconcentration signifie suppression de tout cadre national.
- ☐ B. Répartition des compétences et déploiement territorial sont à distinguer.
- ☐ C. Un pilotage national peut être décliné territorialement.
- ☐ D. La distinction suffit à décrire exhaustivement chaque règle de santé.
- ☐ E. Les deux mots sont interchangeables dans toute organisation.

Q36 — Difficile

Deux régions présentent des besoins différents d'accès aux soins. Quelles propositions décrivent une adaptation territoriale ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Analyser les besoins régionaux.
- ☐ B. Déduire que toute politique nationale devient inutile.
- ☐ C. Reproduire nécessairement les mêmes moyens malgré des besoins différents.
- ☐ D. Confondre adaptation régionale et consultation individuelle.
- ☐ E. Articuler les ressources du territoire avec les orientations nationales.

Q37 — Facile

Quelles associations historiques sont correctes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. 1958 désigne la création d'une caisse locale pour chaque laboratoire.
- ☐ B. 1958 relie CHU, soin, enseignement et recherche.
- ☐ C. 1945 est la date de création de Mon espace santé.
- ☐ D. La construction historique suffit à décrire toutes les règles actuelles.
- ☐ E. 1945 est un repère de protection sociale collective.

Q38 Moyen

Quelles associations entre réforme et apport sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Une chronologie permet de prédire avec certitude les questions d'un examen.
- [ ] B. 2009 : création des CHU pour la première fois.
- [ ] C. 2002 : renforcement des droits des personnes soignées.
- [ ] D. 2002 : suppression de la participation des patients.
- [ ] E. 2009 : organisation territoriale avec les ARS.

Q39 Difficile

Concernant lois de santé et LFSS : (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Toute réforme de santé est obligatoirement une LFSS.
- [ ] B. La LFSS a une périodicité annuelle.
- [ ] C. Une loi générale de santé est garantie exactement tous les cinq ans.
- [ ] D. Les lois de santé et la LFSS n'ont pas le même objet.
- [ ] E. Une réforme élargissant certaines compétences autorise tous les actes sans condition.

Q40 Facile

Quelles associations direction–champ sont exactes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. DGOS et DSS sont deux noms de la même direction.
- [ ] B. DGS : objectifs et politiques de santé publique.
- [ ] C. DGOS : pilotage stratégique de l'offre de soins.
- [ ] D. DSS : cadre de la protection sociale et équilibre financier.
- [ ] E. DGS : remboursement local de chaque assuré.

Q41 Moyen

Quelles associations institution–mission sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. DGCS : synonyme de caisse nationale de l'Assurance maladie.
- [ ] B. DREES : produire des analyses sanitaires et sociales.
- [ ] C. IGAS : organisme de remboursement de tous les médicaments.
- [ ] D. DREES : service de consultation médicale de première ligne.
- [ ] E. DGCS : autonomie et lutte contre l'exclusion.

Q42 Moyen

Quels domaines font partie de l'action des ARS ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Veille et sécurité sanitaire.
- [ ] B. Organisation des soins et du médico-social.
- [ ] C. Production de chaque acte infirmier à la place des équipes.
- [ ] D. Vote exclusif de la loi nationale annuelle.
- [ ] E. Prévention et promotion de la santé.

Q43 **Quelles associations acteur–échelle sont correctes ? (2 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. L'ECDC intervient à l'échelle européenne.
- ☐ B. Tous ces acteurs ont une fonction identique de remboursement.
- ☐ C. Une ARS est une agence mondiale.
- ☐ D. L'UNICEF est une caisse locale de l'Assurance maladie.
- ☐ E. L'OMS intervient à l'échelle mondiale.

Q44 **Quels exemples illustrent une influence européenne en santé ? (2 bonnes réponses)** Moyen

- ☐ A. Le salaire personnel d'un professionnel pris isolément.
- ☐ B. L'adresse d'une CPAM comme institution mondiale.
- ☐ C. Les avertissements sanitaires sur les produits du tabac.
- ☐ D. La protection des données personnelles de santé.
- ☐ E. Le seul planning individuel d'un cabinet.

Q45 **Concernant directive et règlement européens : (2 bonnes réponses)** Difficile

- ☐ A. Une procédure unique ne peut pas être déduite pour tous les textes.
- ☐ B. Reconnaître l'échelle d'un acteur rend sa fonction inutile à connaître.
- ☐ C. Les deux instruments doivent être distingués.
- ☐ D. Chaque exemple permet de reconstruire tout le droit européen.
- ☐ E. Les deux termes sont toujours strictement synonymes.

Qualité et expertise

Q46 **Quelles missions correspondent à la HAS ? (2 bonnes réponses)** Facile

- ☐ A. Imposer mécaniquement le même acte à toute personne.
- ☐ B. Rembourser directement chaque consultation de chaque assuré.
- ☐ C. Être le nom du ministère chargé de la santé.
- ☐ D. Élaborer des recommandations de bonne pratique.
- ☐ E. Participer à la certification des établissements.

Q47 Difficile

Une prise de sang est techniquement réussie mais inutile dans la situation. Quelles analyses sont justes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. La pertinence de son indication peut être insuffisante.
- ☐ B. Qualité et pertinence sont deux mots interchangeables.
- ☐ C. Un acte inutile devient pertinent s'il est répété.
- ☐ D. La qualité technique peut être bonne.
- ☐ E. La réussite technique prouve à elle seule l'utilité.

Q48 Moyen

Quelle lecture correspond à l'efficience ? (1 bonne réponse)

- ☐ A. Examiner les résultats et les ressources ensemble.
- ☐ B. Ignorer la pertinence des actes.
- ☐ C. Assimiler toute baisse de dépense à un bénéfice clinique.
- ☐ D. Choisir toujours le moins cher quels que soient les effets.
- ☐ E. Compter uniquement les actes réalisés.

Financement et prise en charge

Q49 Facile

Quelles propositions distinguent Sécurité sociale et Assurance maladie ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. La Sécurité sociale protège contre plusieurs risques.
- ☐ B. L'Assurance maladie désigne uniquement une mutuelle.
- ☐ C. La Sécurité sociale est le nom d'un service hospitalier.
- ☐ D. L'Assurance maladie est une composante de la Sécurité sociale.
- ☐ E. Les deux expressions sont toujours interchangeables.

Q50 Moyen

Quelles fonctions correspondent à la LFSS et à l'ONDAM ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. La LFSS est une loi votée par le Parlement.
- ☐ B. Ces deux sigles sont les noms de deux complémentaires santé.
- ☐ C. La LFSS est un centre local de consultation.
- ☐ D. L'ONDAM est un objectif de dépenses.
- ☐ E. L'ONDAM est le salaire individuel de tous les soignants.

Q51 Moyen

Quelles associations CNAM–CPAM sont exactes ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Les CPAM interviennent dans la gestion locale des droits des assurés.
- ☐ B. La CNAM participe aux orientations nationales du réseau.
- ☐ C. La maîtrise médicalisée consiste à réduire tout soin sans égard à son utilité.
- ☐ D. CNAM est un autre nom de la DGS.
- ☐ E. Les CPAM votent la LFSS nationale.

Q52 Moyen

Comment interpréter le reste à charge ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Le montant après l'Assurance maladie est toujours le paiement final.
- ☐ B. Une complémentaire peut modifier la somme finalement supportée.
- ☐ C. Un exemple général garantit le remboursement individuel.
- ☐ D. Il faut préciser après quelle prise en charge on raisonne.
- ☐ E. Toute dépense de santé est forcément intégralement couverte.

Q53 Facile

Quelles propositions distinguent complémentaire santé et mutuelle ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Une complémentaire remplace automatiquement tout rôle de l'Assurance maladie.
- ☐ B. La complémentaire peut prendre en charge tout ou partie de certaines dépenses restantes.
- ☐ C. Toutes les complémentaires sont obligatoirement des mutuelles.
- ☐ D. Une mutuelle est le nom de la loi annuelle de financement.
- ☐ E. Une mutuelle peut proposer une complémentaire santé.

Q54 Difficile

Une personne n'avance pas certains frais. Quelles conclusions peut-on tirer ? (2 bonnes réponses)

- ☐ A. Les conditions de couverture doivent être vérifiées.
- ☐ B. Toute dépense présente ou future devient nécessairement gratuite.
- ☐ C. L'absence d'avance prouve qu'aucune complémentaire n'intervient.
- ☐ D. Il faut distinguer avance et prise en charge finale.
- ☐ E. La situation autorise à promettre un taux identique pour tous.

Surveillance et vigilances

Q55 — Moyen

Quelles associations acteur–mission de surveillance sont cohérentes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. L'ANSES produit une expertise sur l'alimentation, l'environnement et le travail.
- [ ] B. Une ARS intervient uniquement à l'échelle mondiale.
- [ ] C. Un nombre d'événements suffit sans aucune analyse.
- [ ] D. La surveillance remplace toute organisation de réponse.
- [ ] E. Santé publique France participe à la surveillance et à la prévention.

Q56 — Facile

Quelles associations vigilance–objet sont correctes ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. L'hémovigilance est un synonyme du financement hospitalier.
- [ ] B. Les risques des dispositifs médicaux relèvent de la matériovigilance.
- [ ] C. La chaîne transfusionnelle relève de l'hémovigilance.
- [ ] D. Les effets et risques des médicaments relèvent de la pharmacovigilance.
- [ ] E. La biovigilance désigne uniquement les salaires des chercheurs.

Q57 — Difficile

Un effet rare est repéré après la mise à disposition d'un médicament. Quelles propositions sont justes ? (2 bonnes réponses)

- [ ] A. Le signalement et l'analyse restent utiles après la mise à disposition.
- [ ] B. L'EFS a pour unique mission de voter les lois.
- [ ] C. L'EMA et l'ANSM sont deux caisses locales de remboursement.
- [ ] D. L'ancienneté d'utilisation garantit un risque nul.
- [ ] E. L'évaluation initiale et la surveillance se complètent.

Recherche et situations de synthèse

Q58 — Facile

Quels acteurs peuvent participer à la recherche en santé ? (3 bonnes réponses)

- [ ] A. Les laboratoires pharmaceutiques.
- [ ] B. Les organismes ou instituts de recherche.
- [ ] C. Les CHU et les universités.
- [ ] D. Exclusivement les caisses locales de remboursement.
- [ ] E. Uniquement les services réalisant des consultations sans autre mission.

Q59 **Quelles propositions distinguent les missions d'un CHU ? (2 bonnes réponses)**

Moyen

- [ ] A. L'enseignement rend le soin inutile.
- [ ] B. La recherche se confond avec le remboursement individuel.
- [ ] C. Le soin et la recherche restent des activités distinctes.
- [ ] D. Tout soin de CHU est automatiquement une procédure expérimentale.
- [ ] E. La formation fait partie de ses missions.

Q60 **Plusieurs habitants rencontrent des délais, une mauvaise transmission de comptes rendus et des difficultés de paiement. Quels liens sont pertinents ? (3 bonnes réponses)**

Difficile

- [ ] A. Relier les comptes rendus à la continuité du parcours.
- [ ] B. Déduire une solution identique pour tous du seul nom du territoire.
- [ ] C. Orienter la question financière vers les interlocuteurs de prise en charge.
- [ ] D. Relier les délais à l'offre et à l'organisation territoriale.
- [ ] E. Confier toutes ces fonctions au seul organisme d'expertise scientifique.

Corrigés argumentés

Système, professionnels et accès

Q01 — Réponses : A, C. Le système de soins est une partie du système de santé, qui inclut aussi pilotage, financement, prévention, information et recherche. La santé mobilise des actions au-delà des consultations et des traitements. A : Vrai. Il comprend aussi des fonctions collectives d'organisation et de prévention. B : Faux. Des politiques et actions collectives contribuent aussi à prévenir. C : Vrai. Elle produit des informations utiles à la protection de la population. D : Faux. La mobilisation des ressources en fait partie. E : Faux. Le système de soins constitue une partie d'un ensemble plus large.

Q02 — Réponses : A, B, D. Améliorer la santé, répondre aux attentes de la population et assurer l'équité. Accès, qualité, sécurité et continuité contribuent à ces objectifs. A : Vrai. La prévention et la réduction des conséquences des maladies y contribuent. B : Vrai. Cela participe à l'équité. C : Faux. Prévention et promotion dépassent cette seule situation. D : Vrai. Des actes isolés ne garantissent pas un suivi cohérent. E : Faux. Une égalité apparente de moyens ne garantit pas une réponse équitable.

Q03 — Réponses : C, D. Les possibilités de déplacement, les délais et les besoins peuvent différer malgré une offre apparemment identique. L'accès doit être apprécié à partir des possibilités concrètes des personnes. A : Faux. Une contrainte matérielle ne permet pas de conclure à une intention. B : Faux. Elle ne montre pas que les habitants peuvent réellement consulter. C : Vrai. L'équité suppose de tenir compte des situations. D : Vrai. L'obstacle de déplacement peut empêcher l'utilisation de l'offre. E : Faux. Elle dépend aussi de l'organisation et des échanges utiles.

Q04 — Réponses : A, D. Médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. La classification des professions ne suffit pas à déterminer tous les actes autorisés. A : Vrai. Cette catégorie n'efface pas leurs compétences propres. B : Faux. Cette déduction est incorrecte. C : Faux. Les actes autorisés ne se déduisent pas de cette opposition simplifiée. D : Vrai. La maïeutique renvoie à cette profession. E : Faux. Ils figurent dans les professions médicales.

Q05 — Réponses : B, D. Il contribue à la régulation de l'exercice, à la tenue du tableau, à la déontologie et à la discipline de sa profession. Il se distingue d'un employeur et d'un organisme de remboursement. A : Faux. Un ordre n'est pas leur employeur. B : Vrai. C'est une fonction de régulation professionnelle. C : Faux. Plusieurs ordres distincts sont présentés. D : Vrai. L'inscription et le suivi de l'exercice relèvent de ses fonctions présentées. E : Faux. Cette fonction ne correspond pas à celle d'un ordre.

Corrigés argumentés

Q06 — Réponses : C. Une même personne combine une activité salariée et une activité libérale. Le lieu de travail ne suffit pas à identifier le statut professionnel. A : Faux. Rémunération individuelle et financement de la structure sont distincts. B : Faux. Un lieu ne suffit pas à connaître le cadre d'exercice. C : Vrai. Les deux modes d'exercice sont associés chez la même personne. D : Faux. L'activité libérale décrite doit aussi être prise en compte. E : Faux. Il décrit une combinaison de modes d'exercice.

Q07 — Réponses : B, D. L'effectif est un nombre de professionnels ; la densité rapporte ce nombre à une population, selon une unité précisée. Une comparaison exige un même champ, une même profession et une unité cohérente. A : Faux. Les délais et les conditions concrètes restent à étudier. B : Vrai. Elle rapporte un nombre de professionnels à la population. C : Faux. Elles ne décrivent pas la même mesure. D : Vrai. La taille du territoire ou de sa population peut influencer ce nombre. E : Faux. Les unités doivent être harmonisées.

Q08 — Réponses : C, E. Une projection décrit un avenir possible fondé sur des hypothèses ; une observation porte sur des données recueillies. La date, le territoire, la profession et le type de mesure doivent accompagner la lecture. A : Faux. Elle est indispensable pour distinguer observations et projections. B : Faux. La projection porte sur une période future. C : Vrai. Il s'agit d'un scénario et non d'une mesure future déjà réalisée. D : Faux. Il ne prédit pas l'accès de chaque personne. E : Vrai. Une évolution de généralistes ne décrit pas automatiquement tous les médecins.

Q09 — Réponses : A, E. Examiner les délais, la disponibilité, les déplacements, la coordination et la compréhension des démarches. Une ressource présente sur une carte peut rester difficile à mobiliser. A : Vrai. Les deux ne sont pas automatiquement équivalents. B : Faux. Le délai ne constitue pas une mesure d'effectif. C : Faux. Le nombre ne résout pas les obstacles décrits. D : Faux. La coordination peut conditionner la continuité et l'orientation. E : Vrai. Ils contribuent à l'accès effectif.

Lieux, modalités et niveaux de recours

Q10 — Réponses : A, B. Établissements de santé, structures médico-sociales et soins de ville. Ces catégories décrivent des organisations et non des niveaux de gravité. A : Vrai. Ils ne se limitent pas aux cabinets. B : Vrai. Il dépasse la seule succession d'actes médicaux. C : Faux. Ils décrivent des lieux et organisations. D : Faux. La présence de soins ne change pas sa finalité médico-sociale. E : Faux. Plusieurs lieux peuvent être articulés dans le temps ou simultanément.

Corrigés argumentés

Q11 — Réponses : A, E. Il renseigne une catégorie d'organisation, mais ne suffit pas à connaître toutes les activités, autorisations ou missions. Il faut distinguer public, privé non lucratif et privé lucratif sans déduire une activité du seul statut. A : Vrai. Ces catégories ne sont pas synonymes. B : Faux. Les autorisations doivent être identifiées spécifiquement. C : Faux. Des organisations de statuts différents peuvent être spécialisées. D : Faux. Le statut privé recouvre des organisations différentes. E : Vrai. Leur statut ne se confond pas avec celui d'une clinique lucrative.

Q12 — Réponses : A, C. MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; réadaptation : récupération et adaptation ; USLD : surveillance médicale importante et durable. Ces finalités se distinguent du statut public ou privé de la structure. A : Vrai. C'est la finalité décrite pour ce secteur. B : Faux. Elle concerne une surveillance importante et durable. C : Vrai. Le sigle regroupe ces activités. D : Faux. C'est l'appellation employée par le support pour le secteur de réadaptation. E : Faux. La spécialisation ne se déduit pas du seul statut.

Q13 — Réponses : A, C. Non. Consultation, examen ou hôpital de jour peuvent se dérouler à l'hôpital sans nuitée. Le lieu hospitalier ne suffit pas à caractériser une hospitalisation conventionnelle. A : Vrai. Le lieu et la modalité sont deux dimensions distinctes. B : Faux. Des prises en charge ambulatoires sont hospitalières. C : Vrai. La prise en charge se déroule sur quelques heures ou la journée. D : Faux. Il faut préciser le mode de prise en charge. E : Faux. Des examens peuvent être réalisés sans hébergement.

Q14 — Réponses : B. Non. L'HAD est une organisation hospitalière au domicile ; une intervention de ville à domicile n'en est pas automatiquement une. L'adresse du soin ne suffit pas à identifier son organisation. A : Faux. Le H signifie hospitalisation. B : Vrai. Le lieu seul ne permet pas cette qualification. C : Faux. Un soin de ville peut aussi être réalisé au domicile. D : Faux. L'HAD illustre cette possibilité. E : Faux. Celle-ci comporte des nuitées dans un établissement.

Q15 — Réponses : A, C, E. Les soins prévus, les relais professionnels, les informations utiles et les conditions de vie au domicile. Le développement de l'ambulatoire suppose une organisation adaptée, et non la seule décision de sortie. A : Vrai. Elles soutiennent la continuité entre équipes. B : Faux. Le parcours se poursuit au-delà de l'établissement. C : Vrai. La suite du parcours doit être organisée. D : Faux. L'entourage et les ressources peuvent différer. E : Vrai. Les conditions de vie influencent la faisabilité du retour.

Q16 — Réponses : A, E. Non. Le besoin appelle une réponse rapide, mais son caractère imprévu ne définit pas à lui seul sa gravité. Programmation et degré d'urgence décrivent deux dimensions différentes. A : Vrai. La gravité doit être appréciée. B : Faux. Elle nécessite une réponse immédiate adaptée. C : Faux. Une prise en charge nécessaire peut être anticipée. D : Faux. Cette équivalence est incorrecte. E : Vrai. C'est l'idée d'une réponse rapide adaptée.

Corrigés argumentés

Q17 — Réponses : C, D. Le service d'accès aux soins participe à la régulation et à l'orientation vers une réponse adaptée aux ressources du territoire. Il ne garantit pas automatiquement un rendez-vous dans un délai identique pour tous. A : Faux. La régulation ne fonctionne pas comme une attribution uniforme. B : Faux. Le SAS est ici un dispositif d'accès et d'orientation. C : Vrai. L'orientation dépend du besoin évalué. D : Vrai. La régulation organise l'orientation. E : Faux. La situation doit être évaluée.

Q18 — Réponses : A, D. Distinguer besoin non programmé et urgence vitale, puis rechercher une orientation adaptée. L'indisponibilité du médecin ne suffit pas à définir la gravité de la situation. A : Vrai. L'orientation doit être adaptée. B : Faux. La disponibilité du cabinet ne définit pas l'état clinique. C : Faux. Certains besoins nécessitent une réponse plus rapide. D : Vrai. Les deux caractéristiques ne se confondent pas. E : Faux. L'exemple ne constitue pas une garantie universelle.

Q19 — Réponses : A, C. Assurer un premier contact, répondre aux besoins courants, prévenir et suivre au plus près de la population. Il mobilise plusieurs professions et ne constitue pas un soin de moindre valeur. A : Vrai. Son rôle dépasse une consultation isolée. B : Faux. Le niveau répond à des besoins et ressources différents. C : Vrai. Le premier recours ne se limite pas à une profession. D : Faux. Ceux-ci relèvent d'une autre catégorie dans le cadre présenté. E : Faux. Il peut intervenir au plus près de la population en ville.

Q20 — Réponses : B, E. Oui. Le niveau de recours dépend de l'expertise et des ressources nécessaires, pas seulement du bâtiment. Un CHU peut aussi réaliser des soins qui ne sont pas de haute spécialisation. A : Faux. Une expertise spécialisée peut être proposée en ville. B : Vrai. Il décrit la complexité et les ressources nécessaires. C : Faux. Un CHU réalise des activités de niveaux variés. D : Faux. Le cas décrit l'illustre. E : Vrai. Le lieu ne fixe pas à lui seul le niveau.

Q21 — Réponses : B, E. Non. L'orientation dépend du besoin de moyens ou d'expertise ; chaque personne ne passe pas par tous les niveaux. Les prises en charge complexes ou particulièrement spécialisées répondent à des situations spécifiques. A : Faux. Le retour d'information et la continuité restent nécessaires. B : Vrai. Les besoins ne sont pas identiques pour tous. C : Faux. Aucun passage systématique n'est requis. D : Faux. Il décrit une fonction de prise en charge. E : Vrai. Complexité et ressources sont les critères utiles.

Corrigés argumentés

Parcours et coordination

Q22 — Réponses : B, E. Soins, prévention personnalisée, orientation, coordination et suivi. Cette fonction peut être exercée par un généraliste ou un spécialiste, en ville ou à l'hôpital. A : Faux. Sa fonction comprend aussi prévention et coordination. B : Vrai. Elle fait partie de son rôle. C : Faux. Les caractéristiques possibles sont plus larges. D : Faux. La coordination articule leurs interventions. E : Vrai. La coordination dépasse l'adressage.

Q23 — Réponses : B, C. Il permet de comprendre la décision, d'ajuster le suivi et d'articuler les interventions. L'aller vers un spécialiste sans retour d'information peut laisser les soins juxtaposés. A : Faux. Les règles financières ne sont pas établies par ce seul document. B : Vrai. C'est un objectif du parcours coordonné. C : Vrai. Le retour d'information soutient la continuité. D : Faux. Le suivi nécessite aussi des échanges en retour. E : Faux. Son rôle de coordination peut se poursuivre.

Q24 — Réponses : A, E. Il organise la cohérence des soins ; les règles précises de prise en charge dépendent de la situation et du cadre applicable. Des accès directs et des situations particulières existent sans annuler l'objectif de continuité. A : Vrai. Ils ne répondent pas à la même question. B : Faux. La continuité reste utile. C : Faux. Le parcours a aussi cette dimension. D : Faux. La situation et le cadre peuvent différer. E : Vrai. Un exemple général n'est pas un calcul individuel.

Q25 — Réponses : A, C. Les dimensions médico-sociales et sociales, dont autonomie, ressources, déplacements et accès aux droits. Le raisonnement porte sur la personne dans son milieu de vie. A : Vrai. Ils concernent notamment l'autonomie et l'accompagnement. B : Faux. Il les englobe. C : Vrai. Ces dimensions sociales influencent le parcours. D : Faux. Le périmètre du parcours de santé est plus large. E : Faux. Le parcours traverse plusieurs lieux et domaines.

Q26 — Réponses : B, C, E. Organiser le soin prévu et explorer les besoins d'aide, les ressources et les déplacements avec la personne. Les dimensions de soins, d'autonomie et de vie quotidienne doivent être reliées. A : Faux. La difficulté quotidienne décrite reste présente. B : Vrai. Elles relèvent des dimensions sociales et médico-sociales. C : Vrai. Il fait partie du parcours de soins inclus dans le parcours global. D : Faux. La continuité appelle une articulation des réponses. E : Vrai. Sa participation contribue à une réponse adaptée.

Corrigés argumentés

Q27 — Réponses : A, C. Relier les besoins des habitants, la surveillance et les ressources locales pour adapter les réponses. Cet exemple illustre une articulation ; il ne constitue pas un protocole unique pour toutes les situations. A : Vrai. Le milieu de vie fait partie de l'analyse. B : Faux. L'information doit pouvoir éclairer des actions adaptées. C : Vrai. L'action dépasse un acte isolé. D : Faux. Les besoins doivent être appréciés individuellement. E : Faux. Des acteurs de ville et du médico-social peuvent participer.

Q28 — Réponses : D, E. La coordination exige des objectifs communs, des liens et des modalités de coopération. Des professionnels voisins peuvent continuer à intervenir sans articuler leurs décisions. A : Faux. La ville comporte aussi des organisations coordonnées. B : Faux. Elle les articule. C : Faux. L'organisation effective des liens reste indispensable. D : Vrai. La coordination ne nécessite pas forcément un bâtiment unique. E : Vrai. Il donne un cadre aux coopérations.

Q29 — Réponses : C, D. La MSP est une organisation de soins pluriprofessionnelle ; la CPTS coordonne des acteurs à l'échelle d'un territoire. Une CPTS dépasse une seule structure et peut relier ville, établissements et médico-social. A : Faux. Leurs périmètres d'organisation diffèrent. B : Faux. Ce rôle correspond à un autre type d'acteur. C : Vrai. Sa portée dépasse le lieu d'une consultation. D : Vrai. Les exemples présentent généralement des professionnels libéraux. E : Faux. Il réunit des activités et des professionnels, généralement salariés dans le cours.

Q30 — Réponses : A, B, D. Accès aux soins, parcours complexes, prévention, crises sanitaires, accompagnement des professionnels et qualité des soins. Ces missions visent les besoins du territoire et le décloisonnement des acteurs. A : Vrai. Cela participe à l'accès aux soins. B : Vrai. Cela soutient les parcours complexes. C : Faux. La CPTS coordonne leurs réponses. D : Vrai. La prévention est une mission présentée. E : Faux. C'est une fonction parlementaire.

Q31 — Réponses : B, D. Faciliter la disponibilité et la circulation des informations utiles au suivi. Un outil numérique soutient la continuité, sans remplacer le dialogue ni le raisonnement professionnel. A : Faux. Le raisonnement reste nécessaire. B : Vrai. La disponibilité des éléments utiles soutient le suivi. C : Faux. Disponibilité d'information et décision de soin sont distinctes. D : Vrai. Il s'agit d'un objectif de ces outils. E : Faux. L'utilité, le destinataire et la confidentialité restent à examiner.

Q32 — Réponses : B, C, D. Non. Il faut vérifier le destinataire, l'utilité pour la prise en charge et le cadre de confidentialité. La protection du canal ne justifie pas un partage sans limite. A : Faux. L'équipement ne suffit pas à légitimer le partage. B : Vrai. La disponibilité technique ne suffit pas. C : Vrai. La sécurité du canal ne le remplace pas. D : Vrai. Le destinataire doit être approprié. E : Faux. Cela ne vérifie ni la pertinence ni le destinataire.

Corrigés argumentés

Q33 — Réponses : C, D. Un document accessible n'est pas automatiquement utile à tout destinataire ni à diffuser sans limite. La coordination exige un choix d'informations pertinentes et un échange adapté. A : Faux. Un partage excessif peut être inapproprié. B : Faux. Ce sont deux dimensions distinctes. C : Vrai. Une présence dans l'outil ne garantit pas cette utilité. D : Vrai. Le numérique ne remplace pas le dialogue. E : Faux. Des liens et décisions doivent aussi être organisés.

Pilotage, histoire et institutions

Q34 — Réponses : B, C. Le Parlement vote les lois ; le ministère conduit les politiques nationales ; l'ARS les met en œuvre et les adapte au niveau régional. Les réponses concrètes mobilisent aussi les acteurs du territoire. A : Faux. Ils organisent les interventions concrètes. B : Vrai. Elle articule orientations et besoins du territoire. C : Vrai. Il exerce une fonction législative. D : Faux. Sa fonction est celle du pilotage national. E : Faux. Cette fonction appartient au Parlement.

Q35 — Réponses : B, C. La déconcentration décrit un déploiement territorial du pilotage national ; la décentralisation renvoie à une autre répartition des compétences. Cette distinction ne réduit pas toute l'organisation sanitaire à une chaîne unique. A : Faux. Le pilotage national est au contraire conservé. B : Vrai. Les deux termes ne sont pas synonymes. C : Vrai. C'est la logique de déconcentration utilisée dans le cours. D : Faux. Le cours fournit ici un repère conceptuel. E : Faux. Ils décrivent des logiques différentes.

Q36 — Réponses : A, E. Les besoins et les ressources régionaux diffèrent ; la mise en œuvre doit en tenir compte. Un cadre commun n'impose pas une copie uniforme de chaque réponse locale. A : Vrai. Ils orientent l'organisation de la réponse. B : Faux. Elle conserve une fonction de cadre. C : Faux. L'adaptation serait alors ignorée. D : Faux. Ce sont des échelles d'action distinctes. E : Vrai. Ces deux échelles se complètent.

Q37 — Réponses : B, E. 1945 : construction de la Sécurité sociale ; 1958 : réforme hospitalo-universitaire et création des CHU. Les repères historiques servent à comprendre les évolutions et leurs fonctions. A : Faux. La réforme hospitalo-universitaire a un autre objet. B : Vrai. Ces trois missions sont articulées. C : Faux. Ce repère ne correspond pas à cet outil. D : Faux. Un repère ne remplace pas l'étude du cadre applicable. E : Vrai. Il renvoie à la construction de la Sécurité sociale.

Q38 — Réponses : C, E. 2002 renforce la place et les droits des patients ; 2009 est un repère d'organisation territoriale, notamment autour des ARS et des ESPIC. Il faut comprendre les apports sans transformer une chronologie en garantie de contenu d'examen. A : Faux. Aucune telle garantie ne peut être déduite. B : Faux. Le repère hospitalo-universitaire est 1958. C : Vrai. C'est l'apport historique présenté. D : Faux. L'apport présenté va vers le renforcement de leurs droits. E : Vrai. La loi HPST constitue ce repère.

Corrigés argumentés

Q39 — Réponses : B, D. Non. Il faut distinguer les évolutions législatives de santé et la LFSS annuelle, qui fixe notamment un cadre et des objectifs financiers. Une périodicité évoquée dans un support ne devient pas une règle automatique. A : Faux. Leurs objets ne se confondent pas. B : Vrai. Elle porte notamment sur des objectifs financiers de protection sociale. C : Faux. Cette automaticité n'est pas établie. D : Vrai. Elles doivent être distinguées. E : Faux. L'élargissement ne permet pas cette généralisation.

Q40 — Réponses : B, C, D. DGS : santé publique ; DGOS : offre de soins ; DSS : protection sociale et cadre financier. Les sigles proches renvoient à des fonctions distinctes. A : Faux. Leurs champs doivent être distingués. B : Vrai. Elle intervient notamment face aux menaces sanitaires. C : Vrai. Elle s'intéresse à son adéquation aux besoins. D : Vrai. Son champ ne se réduit pas à une consultation clinique. E : Faux. Cette fonction relève d'un autre type d'organisme.

Q41 — Réponses : B, E. DREES : études et statistiques ; DGCS : cohésion sociale ; IGAS : inspection des affaires sociales. Partir de la fonction permet d'éviter la confusion entre organismes aux sigles proches. A : Faux. Direction ministérielle et caisse nationale sont distinctes. B : Vrai. Études, évaluation et statistiques composent son champ. C : Faux. Il s'agit d'un corps d'inspection. D : Faux. Son rôle présenté est la production de connaissances. E : Vrai. Ces thèmes relèvent de la cohésion sociale.

Q42 — Réponses : A, B, E. Offre de soins, accompagnement médico-social, prévention et promotion, veille et sécurité sanitaire. Ces domaines permettent d'articuler organisation et protection de la santé dans la région. A : Vrai. Les ARS participent à la surveillance et aux réponses aux crises. B : Vrai. Ces deux domaines appartiennent à leurs missions. C : Faux. L'organisation régionale ne se confond pas avec l'acte clinique. D : Faux. Cette fonction n'est pas celle de l'ARS. E : Vrai. L'action régionale ne se limite pas aux établissements.

Q43 — Réponses : A, E. OMS : mondiale ; ECDC : européenne ; ARS : régionale. L'échelle d'intervention et la fonction doivent être identifiées ensemble. A : Vrai. Il participe notamment à la surveillance des maladies. B : Faux. Leurs missions sont différentes. C : Faux. Son échelle est régionale. D : Faux. C'est un acteur international associé notamment à l'enfance. E : Vrai. Son nom est Organisation mondiale de la santé.

Q44 — Réponses : C, D. Les avertissements sanitaires sur le tabac et la protection des données personnelles, dont les données de santé. Ces exemples montrent que certaines règles dépassent l'échelon national. A : Faux. Il ne constitue pas l'exemple d'influence européenne présenté. B : Faux. Une caisse locale n'est pas une institution mondiale. C : Vrai. Ils figurent parmi les exemples d'influence européenne. D : Vrai. Le cadre européen est pertinent pour ces données. E : Faux. Cet exemple ne décrit pas en lui-même une règle européenne.

Corrigés argumentés

Q45 — Réponses : A, C. Non. Il faut les distinguer et ne pas leur appliquer automatiquement une procédure unique. La distinction entre ces instruments ne décrit pas à elle seule toute la hiérarchie des normes. A : Vrai. Un exemple ne décrit pas tous les mécanismes juridiques. B : Faux. Échelle et fonction se complètent. C : Vrai. Leur dénomination ne doit pas être rendue interchangeable. D : Faux. Le périmètre du cours est plus limité. E : Faux. Cette assimilation est erronée.

Qualité et expertise

Q46 — Réponses : D, E. Expertise scientifique, évaluation, recommandations de bonne pratique, certification et amélioration de la qualité et de la sécurité. La Haute Autorité de santé se distingue du ministère et d'une caisse de remboursement. A : Faux. La situation individuelle reste à analyser. B : Faux. Ce n'est pas une caisse d'Assurance maladie. C : Faux. Il s'agit d'un organisme d'expertise distinct. D : Vrai. Elles éclairent les décisions de soins. E : Vrai. C'est une mission d'évaluation présentée.

Q47 — Réponses : A, D. La qualité concerne la réalisation du soin ; la pertinence concerne son utilité et son adaptation au besoin. Un acte bien réalisé peut rester inapproprié dans une situation donnée. A : Vrai. L'absence d'utilité concerne l'adaptation au besoin. B : Faux. Ils répondent à des questions différentes. C : Faux. La répétition ne crée pas de bénéfice attendu. D : Vrai. L'acte est décrit comme correctement réalisé. E : Faux. Deux jugements distincts sont nécessaires.

Q48 — Réponses : A. Elle met en relation les résultats obtenus avec les ressources mobilisées. Réduire une dépense sans considérer les résultats ne suffit pas à démontrer une amélioration. A : Vrai. Leur relation constitue le raisonnement d'efficience. B : Faux. Des actes sans bénéfice mobilisent aussi des ressources. C : Faux. Une dépense moindre ne prouve pas un meilleur soin. D : Faux. Le résultat ne peut pas être ignoré. E : Faux. La quantité seule ne décrit pas l'efficience.

Financement et prise en charge

Q49 — Réponses : A, D. Non. Elle est une composante d'une protection sociale couvrant plusieurs risques de la vie. La partie ne doit pas être confondue avec l'ensemble. A : Vrai. Elle dépasse la seule prise en charge des soins. B : Faux. Couverture obligatoire et complémentaire doivent être distinguées. C : Faux. Elle constitue un système de protection sociale. D : Vrai. Leurs périmètres ne sont pas identiques. E : Faux. Cela effacerait la différence de périmètre.

Corrigés argumentés

Q50 — Réponses : A, D. La LFSS est la loi de financement de la Sécurité sociale ; l'ONDAM est l'objectif national de dépenses d'Assurance maladie. Ce sont des éléments du cadre financier, pas des organismes de remboursement. A : Vrai. Son objet concerne le financement de la protection sociale. B : Faux. Leur fonction relève du cadre financier. C : Faux. Le sigle désigne une loi. D : Vrai. Il ne désigne pas une caisse. E : Faux. Il s'agit d'un objectif national.

Q51 — Réponses : A, B. La CNAM pilote au niveau national ; les CPAM accompagnent les assurés et mettent en œuvre localement la gestion des droits et prestations. Une direction ministérielle, une caisse nationale et une caisse locale sont trois acteurs distincts. A : Vrai. Elles accompagnent la mise en œuvre des prestations. B : Vrai. Son échelle est nationale. C : Faux. Elle recherche l'efficience en préservant pertinence, qualité et sécurité. D : Faux. Caisse et direction ministérielle sont distinctes. E : Faux. Le vote relève du Parlement.

Q52 — Réponses : B, D. La somme restant après l'Assurance maladie peut différer de celle restant après une complémentaire. Le calcul dépend du niveau considéré et de la couverture applicable. A : Faux. Une complémentaire peut intervenir. B : Vrai. Elle peut couvrir une partie de dépenses non prises en charge auparavant. C : Faux. Les conditions applicables doivent être vérifiées. D : Vrai. La notion dépend de cette référence. E : Faux. Une prise en charge totale ne peut pas être supposée.

Q53 — Réponses : B, E. La complémentaire désigne une couverture ; la mutuelle est un type d'organisme pouvant la proposer. Toutes les complémentaires ne sont pas des mutuelles. A : Faux. Les niveaux de prise en charge doivent être distingués. B : Vrai. Cela dépend des conditions de la couverture. C : Faux. Plusieurs types d'organismes peuvent intervenir. D : Faux. Ce sont deux objets différents. E : Vrai. L'organisme et la couverture sont liés sans être identiques.

Q54 — Réponses : A, D. Non. Modalité de paiement et niveau de remboursement doivent être distingués. Un obstacle financier appelle une orientation adaptée, sans promesse de gratuité fondée sur un exemple général. A : Vrai. Elles déterminent les droits et montants applicables. B : Faux. Cette généralisation n'est pas justifiée. C : Faux. Elle ne permet pas de connaître les niveaux de prise en charge. D : Vrai. L'absence d'avance ne décrit pas toutes les dépenses couvertes. E : Faux. Les règles précises ne se déduisent pas de ce seul constat.

Corrigés argumentés

Surveillance et vigilances

Q55 — Réponses : A, E. Recueillir et analyser des informations pour suivre l'état de santé et les risques, repérer des signaux et éclairer la réponse. Surveiller ne se limite pas à compter ; l'information doit soutenir prévention et action. A : Vrai. Ces champs participent à la sécurité sanitaire. B : Faux. Elle participe à la surveillance régionale. C : Faux. L'analyse permet d'interpréter les informations. D : Faux. Elle éclaire l'action sans s'y substituer. E : Vrai. Son action concerne la santé publique nationale.

Q56 — Réponses : B, C, D. Pharmacovigilance : médicaments ; matériovigilance : dispositifs médicaux ; hémovigilance : chaîne transfusionnelle et produits sanguins concernés. Le type de produit ou d'activité oriente la vigilance pertinente. A : Faux. Son objet est la sécurité transfusionnelle. B : Vrai. L'objet est distinct de celui d'un médicament. C : Vrai. Elle concerne le sang et les produits concernés. D : Vrai. Le préfixe renvoie ici au médicament. E : Faux. Elle concerne des activités et produits biologiques, notamment les greffes.

Q57 — Réponses : A, E. Des effets rares peuvent être repérés plus tard ; la surveillance complète l'évaluation initiale. Une utilisation ancienne ne démontre pas l'absence de tout risque. A : Vrai. Ils contribuent à repérer les risques. B : Faux. Il intervient notamment dans la collecte et la distribution des produits sanguins labiles. C : Faux. Ce sont des acteurs de la sécurité des médicaments à des échelles distinctes. D : Faux. Des risques peuvent être repérés après une utilisation plus large. E : Vrai. L'une ne rend pas l'autre inutile.

Recherche et situations de synthèse

Q58 — Réponses : A, B, C. CHU et universités, organismes ou instituts de recherche et laboratoires pharmaceutiques. Leurs activités de recherche s'articulent avec d'autres fonctions sans s'y confondre. A : Vrai. Ils participent à la recherche et à l'innovation. B : Vrai. Ils contribuent à la production de connaissances. C : Vrai. La recherche fait partie de leurs missions présentées. D : Faux. Le champ décrit est plus large et ne se réduit pas à ces caisses. E : Faux. La recherche mobilise des organisations spécifiques et variées.

Q59 — Réponses : C, E. Soin, enseignement et recherche. Ces missions sont reliées mais ne sont pas trois noms pour le même acte. A : Faux. Les missions se complètent. B : Faux. Ce sont des fonctions différentes. C : Vrai. Leur articulation ne les rend pas identiques. D : Faux. Le lieu ne suffit pas à qualifier l'acte. E : Vrai. Elle correspond à l'enseignement.

Corrigés argumentés

Q60 — Réponses : A, C, D. À quelle échelle intervient-il, quelle fonction remplit-il et avec quels acteurs s'articule-t-il ? Cette méthode relie la situation aux ressources adaptées sans confondre coordination, financement et expertise. A : Vrai. Le retour d'information soutient la coordination. B : Faux. Les besoins concrets doivent être examinés. C : Vrai. Elle ne se résout pas par la seule expertise clinique. D : Vrai. Ces dimensions peuvent contribuer à l'accès effectif. E : Faux. Les fonctions et interlocuteurs diffèrent.